

Реализация национального проекта здравоохранения в подготовке медицинских кадров

Н.А. Касимовская, Е.В. Фомина, Е.А. Шустикова, В.А. Решетников

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), Москва, Российская Федерация



АННОТАЦИЯ

Обоснование. Российская система здравоохранения претерпевает значительные изменения, связанные с цифровой трансформацией общества, постановкой новых стратегических задач сохранения здоровья, что требует новых подходов в подготовке медицинских кадров (МК) в рамках дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение».

Цель. Изучить и предложить направления совершенствования подготовки МК по приоритетным вопросам охраны здоровья населения в соответствии со стратегическими задачами национального проекта.

Методы. Проведено анкетирование экспертов ($n=21$) учебно-методической комиссии «Общественное здоровье и здравоохранение» Координационного Совета в области образования «Здравоохранение и медицинские науки» из 20 вузов, выпускающих МК. Исследование проведено в 2 этапа: на первом этапе проведен анализ тем дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» в образовательных организациях высшего медицинского образования, на втором этапе изучали применение современных цифровых и информационных технологий в деятельности медицинских организаций, аффилированных с вузами экспертов.

Результаты. В ходе анкетирования выявлено, что не в полном объеме преподаются темы: «Трансформация процессов первичного звена здравоохранения» (67,0%), «Цифровизация здравоохранения» (77,0%), «Передача функций между медицинским персоналом» (86,0%), «Применение бережливых технологий в медицинских организациях» (87,0%), «Соблюдение преемственности между этапами оказания медицинской помощи» (95,5%), темы раздела диспансеризации. Кроме того, тема «Проведение скринингового исследования на антитела к гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше» практически не реализуется (35,2%). Были выявлены проблемы в развитии цифровизации здравоохранения: «Автоматизация различных отчетов» (88,2%), «Поддержка процесса осуществления приема/посещения» (76,4%), «Использование телеконсультаций врач–врач» (64,7%), «Использование телеконсультаций врач–фельдшер» (58,8%), «Применение дронов для доставки биоматериалов до лаборатории» (42,0%), «Единый реестр зарегистрированных лиц» (76,4%), «Персонифицированный учет медицинской помощи, включая высокотехнологичную медицинскую помощь» (70,5%), «Реестр электронных медицинских документов» (82,3%), «Гибридная реабилитация с применением телемедицинских технологий» (47,0%).

Заключение. Для совершенствования подготовки МК в условиях реформирования российской системы здравоохранения целесообразно рекомендовать образовательным организациям высшего медицинского образования включить в рабочие программы дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» следующие темы: «Трансформация процессов первичного звена здравоохранения», «Цифровизация здравоохранения», «Проведение скринингового исследования на антитела к гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше», «Передача функций между медицинским персоналом», «Применение бережливых технологий в медицинских организациях», «Соблюдение преемственности между этапами оказания медицинской помощи», «Диспансеризация ветеранов боевых действий».

Ключевые слова: подготовка медицинских кадров; общественное здоровье и здравоохранение; реформы здравоохранения; национальный проект.

Как цитировать:

Касимовская Н.А., Фомина Е.В., Шустикова Е.А., Решетников В.А. Реализация национального проекта здравоохранения в подготовке медицинских кадров // Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. 2026. Т. 34, № 1. С. 91–98. DOI: 10.17816/PAVLOVJ698125
EDN: FQUGSP

DOI: <https://doi.org/10.17816/PAVLOVJ698125>

EDN: FQUGSP

Implementation of the National Health Project in Training of Medical Personnel

Nataliya A. Kasimovskaya, Elena V. Fomina, Elena A. Shustikova, Vladimir A. Reshetnikov

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenovskiy University), Moscow, Russian Federation

ABSTRACT

BACKGROUND: The Russian healthcare system is undergoing significant changes associated with the digital transformation of society and setting new strategic tasks for preserving health, which requires new approaches to the training of medical personnel (MP) in the discipline 'Public Health and Healthcare'.

AIM: To study and propose directions for improvement of MP training on the priority issues of public health protection in consistence with strategic tasks of the national project.

METHODS: Twenty-one experts from the 'Public Health and Healthcare' Educational and Methodological Commission of the Coordinating Council for Education in 'Healthcare and Medical Sciences' from 20 universities producing medical workers, were surveyed. The study was conducted in two stages: the first involved an analysis of the topics included in the 'Public Health and Healthcare' discipline at higher medical education institutions, and the second involved studying the use of modern digital and information technologies in the activities of medical organizations affiliated with the experts' universities.

RESULTS: The survey revealed that the following topics are taught not in full volume: 'Transformation of Primary Healthcare Processes' (67.0%), 'Digitalization of Healthcare' (77.0%), 'Delegation of Functions between Medical Personnel' (86.0%), 'Use of Lean Technologies in Medical Organizations' (87.0%), 'Maintaining Continuity Between Stages of Medical Care' (95.5%), and the topics concerning prophylactic medical examination service. Furthermore, the topic of 'Screening for Hepatitis C Antibodies in Citizens Aged 25 and Older' is practically not realized (35.2%). The following problems in the digitalization of healthcare were identified: 'Automation of various reports' (88.2%), 'Support for the appointment/visit process' (76.4%), 'Use of doctor-doctor teleconsultations' (64.7%), 'Use of doctor-paramedic teleconsultations' (58.8%), 'Use of drones for delivery of biomaterials to the laboratory' (42.0%), 'Unified registry of registered persons' (76.4%), 'Personalized accounting of medical care, including high-tech medical care' (70.5%), 'Registry of electronic medical documents' (82.3%), 'Hybrid rehabilitation using telemedicine technologies' (47.0%).

CONCLUSION: To improve the training of medical personnel in the context of the reformation of the Russian healthcare system, it is advisable that the program 'Public Health and Healthcare' of higher medical education institutions include the following topics: 'Transformation of Primary Healthcare Processes', 'Digitalization of Healthcare,' 'Screening for Hepatitis C Antibodies in Citizens Aged 25 and Older,' 'Delegation of Functions Between Medical Personnel,' 'Use of Lean Technologies in Medical Organizations,' 'Maintaining Continuity Between Stages of Medical Care,' and 'Medical Examinations of Combat Veterans'.

Keywords: training of medical personnel; public health and healthcare; healthcare reforms; national project.

To cite this article:

Kasimovskaya NA, Fomina EV, Shustikova EA, Reshetnikov VA. Implementation of the National Health Project in Training of Medical Personnel. *I.P. Pavlov Russian Medical Biological Herald*. 2026;34(1):91–98. DOI: 10.17816/PAVLOVJ698125 EDN: FQUGSP

ОБОСНОВАНИЕ

Сохраняющиеся угрозы эпидемической безопасности, демографические вызовы, технологический прогресс и цифровизация всех сфер жизнедеятельности, изменение системы ценностей, необходимость достижения технологического суверенитета, а также национальные цели развития Российской Федерации (РФ), направленные на сохранение здоровья и благополучия людей, цифровую трансформацию общества, создание комфортной и безопасной среды, диктуют новые требования к системе высшего образования, в том числе медицинского [1]. В подготовке высококвалифицированных специалистов сферы здравоохранения стратегической целью становится обеспечение качества медицинского образования с учетом современных мировых тенденций, подходов, научно-технического развития и трансформации российской системы здравоохранения [2]. Драйвером переосмысления привычных подходов в системе образования и триггером целого ряда новых требований к работе образовательных организаций, в частности в системе высшего образования, стала пандемия новой коронавирусной инфекции (англ.: *COronaVirus Disease 2019*, COVID-19) [3]. В то же время процессы, происходящие в обществе, в том числе геополитические, социально-экономические, всегда оказывают значительное влияние на образование [4]. В настоящее время подготовка врача должна быть направлена на приобретение компетенций не только по анализу и оценке состояния здоровья населения, но и по поиску рациональных путей повышения качества медицинской помощи, совершенствования охраны, укрепления и восстановления здоровья как населения в целом, так и его отдельных групп [5, 6].

Научная и учебная дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение», изучающая широкий спектр социальных, организационных, экономических, правовых, этических и других проблем медицины, здоровья населения, его мониторинга, охраны и восстановления, является одной из основополагающих дисциплин в подготовке медицинских кадров (МК) [7]. «Общественное здоровье и здравоохранение» как дисциплина и наука, находясь на стыке социальных, политических и экономических проблем общества на всех этапах своего становления, отражает все происходящие изменения в обществе [5].

С начала 2025 года реализуется Национальный проект (НП) России «Продолжительная и активная жизнь». Федеральным органом исполнительной власти, ответственным за реализацию данного НП, выступает Министерство здравоохранения (МЗ) РФ, непосредственным руководителем является министр здравоохранения РФ М.А. Мурашко. Для изучения готовности к реализации данного НП и в целях повышения качества и доступности медицинской помощи по итогам заседания Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических

высших учебных заведений» в г. Барнауле 07 октября 2024 года министром здравоохранения РФ М.А. Мурашко было дано поручение руководителям образовательных организаций высшего медицинского образования пересмотреть профессиональные образовательные программы на предмет включения приоритетных вопросов отечественного здравоохранения (№ 155 от 24.10.2024).

Цель — изучить и предложить направления совершенствования подготовки медицинских кадров по приоритетным вопросам охраны здоровья населения в соответствии со стратегическими задачами национального проекта.

МЕТОДЫ

В период с 17 по 21 ноября 2025 года проводилось анкетирование экспертов ($n=21$) учебно-методической комиссии «Общественное здоровье и здравоохранение» Координационного Совета в области образования «Здравоохранение и медицинские науки». Из 56 вузов РФ, выпускающих МК, проанкетированы эксперты 20 ведущих образовательных учреждений: Москвы (6 вузов), Санкт-Петербурга (3 вуза), Воронежа (1 вуз), Саратова (1 вуз), Самары (1 вуз), Казани (1 вуз), Донецка (1 вуз), Луганска (1 вуз), Рязани (1 вуз), Кубани (1 вуз), Челябинска (1 вуз), Уфы (1 вуз), Хабаровска (1 вуз).

Критерии отбора экспертов: наличие не менее 10 лет стажа преподавания дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение», членство в учебно-методической комиссии, добровольное информированное согласие.

Исследование было проведено в 2 этапа:

1 этап. Анализ тем дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» в образовательных организациях высшего медицинского образования (ООВМО);

2 этап. Изучение применения современных цифровых и информационных технологий в деятельности медицинских организаций РФ, аффилированных с вузами.

Для проведения исследования были разработаны экспертные карты: «Карта анализа преподавания тем дисциплины «общественное здоровье и здравоохранение» в образовательных организациях» и «Карта оценки применения современных цифровых и информационных технологий в деятельности территориальных медицинских организаций, аффилированных с вузом», которые включали вопросы реализации стратегических задач здравоохранения. Экспертные карты разрабатывались в соответствии с поручением министра здравоохранения М.А. Мурашко № 155 от 24.10.2024 и на основании материалов доклада министра на Международной выставке-форуме «Россия».

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием программного обеспечения Office Excel 2024 (Microsoft Corp., США). Использованы методы описательной статистики, данные

представлены в виде абсолютного количества случаев (n), распространенности признака (%), среднего значения (M), с квадратическим отклонением (SD).

РЕЗУЛЬТАТЫ

При анализе результатов анкетирования экспертов выявлено, что при подготовке МК в полном объеме реализуются темы: «Нормативные правовые документы в области охраны здоровья», «Информация о современных подходах к снижению смертности населения», «Проведение диспансеризации» (табл. 1).

В то же время необходимо отметить, что тема «Проведение диспансеризации» не всегда включает такие вопросы, как «Углубленная диспансеризация» (94,1%) и «Диспансеризация граждан репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья» (94,1%). Тема «Проведение скринингового исследования на антитела к гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше» практически не входит в рабочие программы дисциплины и, по данным анкетирования респондентов, реализуется только в каждом третьем случае. Выявлено, что в рабочих программах дисциплины не освещается тема «Диспансеризация с использованием выездных медицинских бригад» практически в каждом четвертом случае. Вопросы темы «Диспансеризация ветеранов боевых действий» обсуждаются при подготовке МК на всех уровнях высшего образования только в каждом втором случае. По результатам анкетирования выявлено, что вопросы темы «Приоритизация в отношении лиц трудоспособного возраста с 40 до 65 лет, которые в течение последних 2-х лет не посещали медицинские организации и не проходили профилактические мероприятия», обсуждаются при подготовке МК на всех уровнях высшего образования только в каждом втором случае. При этом необходимо отметить, что данные темы являются приоритетными направлениями Национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», реализуемого в здравоохранении с начала 2025 года.

Анализ преподавания базовых принципов организации первичного звена здравоохранения выявил, что в 100% случаев преподаются такие темы, как «Оказание медицинской помощи по принципу приближенности к месту жительства», «Применение порядков оказания медицинской помощи по профилю», «Предоставление гарантированного объема медицинской помощи» (рис. 1).

В то же время установлено, что при подготовке МК не всегда изучаются такие темы, как «Транспортная доступность медицинских организаций», «Применение медицинских информационных систем», «Применение стандартов оказания медицинской помощи», «Применение клинических рекомендаций», «Обеспеченность медицинскими работниками с соответствующим уровнем квалификации».

В том числе только в 82,3±9,4% случаев изучается обеспеченность специалистами с высшим медицинским

образованием, тогда как обеспеченность специалистами со средним медицинским образованием изучается недостаточно — только в 70,5±11,4% случаев.

Анализ трансформации процессов первичного звена здравоохранения в медицинских организациях, аффилированных с вузами, выявил, что автоматизация различных отчетов, которые должен формировать медицинский работник, введена в 88,2±8,1% случаев, информационная поддержка процесса осуществления приема/посещения реализуется в 76,4±12,3% случаев, рутинное применение телемедицинских технологий (в диагностике заболеваний по документам) встречается в 70,5±11,4% случаев, использование телеконсультаций врач–врач с привлечением «узких» специалистов Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) по соответствующим профилям реализуется в 64,7±11,9% случаев, использование телеконсультаций врач–фельдшер фельдшерско-акушерского пункта в помощи «узких» специалистов с привлечением НМИЦ по соответствующим профилям выявлено в 58,8±12,3% случаев, применение дронов для доставки биоматериалов до лаборатории реализуется только в 42,0±12,4% случаев. Передача функций между медицинским персоналом обеспечена через перераспределение функций между медицинскими работниками (делегирование полномочий от врача среднему медицинскому персоналу) в 94,1±5,8% случаев.

Внедрение вопросов цифровизации здравоохранения на территориях осуществляется поэтапно, о чем свидетельствуют полученные результаты: сведения об оказанной медицинской помощи и ее стоимости имеются в 82,3±9,4% территорий, сведения из Федерального единого реестра зарегистрированных лиц — в 76,4±10,6%, сведения из Федерального персонифицированного учета медицинской помощи (включая высокотехнологичную медицинскую помощь) — в 70,5±11,4% случаев, сведения из регистров, из Реестра электронных медицинских документов — в 82,3±9,4%, сведения Федеральных медицинских организаций — в 70,5±11,4%. Персональная маршрутизация пациентов проводится на 76,4±10,6% территорий РФ.

Проактивное информирование лиц, попадающих в зону социальной помощи (социальной льготы), ведется в 76,4% случаев. Проактивное информирование граждан в целях стимулирования раннего обращения пациентов за медицинской помощью проводится в 88,2±8,1% случаев. Проактивное информационное сопровождение каждого гражданина в процессе получения медицинских услуг по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) указывают 76,4±10,6% территорий РФ. Обеспечение информационного сопровождения застрахованных лиц в рамках прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации отмечено в 94,1±5,8% случаев. Приоритизация и ранжирование групп пациентов для выделения приоритетной группы коморбидных пациентов для прохождения диспансерного наблюдения указаны в 82,3±9,4% территорий РФ. Элементы

Таблица 1. Реализация тем дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» в образовательных организациях высшего медицинского образования

Темы	M $\pm$ SD, %
Нормативные правовые документы в области охраны здоровья	100,0
Информация о современных подходах к снижению смертности населения	100,0
Проведение диспансеризации, включая:	100,0
– углубленную диспансеризацию	94,1 $\pm$ 5,8
– диспансеризацию граждан репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья	94,1 $\pm$ 5,8
– использование выездных медицинских бригад	76,4 $\pm$ 10,6
– диспансерное наблюдение работающих граждан	100,0
Приоритезация в отношении лиц трудоспособного возраста с 40 до 65 лет, которые в течение последних двух лет не посещали медицинские организации и не проходили профилактические мероприятия	58,8 $\pm$ 12,3
Диспансеризации ветеранов боевых действий	41,0 $\pm$ 12,2
Проведение скринингового исследования на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше	35,2 $\pm$ 11,9

**Рис. 1.** Преподавание базовых принципов организации первичного звена здравоохранения в подготовке медицинских кадров в образовательных организациях высшего медицинского и фармацевтического образования (%).

цифрового профиля пациента в медицинских организациях имеются в 94,1 $\pm$ 5,8% случаев, при этом сведения о социальном статусе пациента/инвалидности — диагноз/решение медико-социальной экспертизы указаны в 76,4 $\pm$ 10,6%, история анализов, исследований — в 82,3 $\pm$ 9,4%, данные о вакцинации — в 70,5 $\pm$ 11,4% случаев, персональные данные имеются в 88,2 $\pm$ 8,1% случаев, цифровой полис ОМС имеется в 82,3 $\pm$ 9,4% случаев. «Модель пациента, включающая группы, факторы риска, данные о наследственных заболеваниях, клинические

данные» используется в 70,5 $\pm$ 11,4% случаев. «Жизненно важные показатели, статусы и дневниковые записи (рост, вес, группа крови, аллергия, давление, хронические статусы, принимаемые лекарства)» используются в 88,2 $\pm$ 9,4% случаев. Тема «Гибридная реабилитация с применением телемедицинских технологий» встречается только в 47,0 $\pm$ 12,4% случаев, а «Иммерсивные технологии (виртуальная, дополненная и смешанная реальности)» — в 53,0 $\pm$ 12,4%, «Технологии мозг-компьютер-интерфейс» — в 58,8 $\pm$ 12,3% случаев.

Внедрение бережливых технологий в медицинских организациях осуществляется посредством изменения правил маршрутизации пациентов в 88,2±8,1% случаев. Вежливая и открытая регистратура внедрена на всех территориях (100%), прием по времени предварительной записи реализуется в 94,1±5,8% случаев. Стандартизация работы и рабочих мест (системы 5S, 6S) реализуется в 70,5±11,4% случаев, тогда как бережливые инструменты Kaizen, JIT, Kanban, Takt time, Heijunka, Poka-Yoke, VSM, PDCA, SMED, TPM и др. применяются не во всех медицинских организациях (82,3±9,4%).

Внесение дополнений в программы подготовки медицинских специалистов (повышения квалификации, профессиональной переподготовки) с целью обеспечения требуемого уровня компетенций обеспечивается в 88,2±8,1% случаев.

Результаты анализа преподавания раздела «Соблюдение преемственности между этапами оказания медицинской помощи» показали, что такие темы, как «Передача сведений о вызовах скорой медицинской помощи лицами из числа прикрепленного населения в первичное звено здравоохранения», «Передача сведений из стационара об экстренных госпитализациях лиц из числа прикрепленного населения в первичное звено здравоохранения» и «Полная передача данных из первичного звена здравоохранения о пациентах для организации плановой госпитализации в стационар», преподаются в полном объеме (100%). Тогда как темы «Оперативное взаимодействие со скорой медицинской помощью при выявлении экстренного состояния пациента» и «Передача данных из стационара о пациентах, перенесших острое сердечно-сосудистое событие, в первичное звено здравоохранения» преподаются только в 88,2±8,1% случаев.

ОБСУЖДЕНИЕ

Состояние здоровья населения в XXI веке на фоне социально-экономических преобразований, трансформации системы здравоохранения повышает значимость подготовки врачей и организаторов здравоохранения всех уровней по проблемам общественного здоровья, организации, управления и экономики здравоохранения [8]. Исследование подтверждает необходимость введения приоритетных вопросов здравоохранения в реализацию дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение», так как не в полном объеме преподаются следующие темы: «Базовые принципы организации первичного звена здравоохранения», «Трансформация процессов первичного звена здравоохранения», «Цифровизация здравоохранения», «Передача функций между медицинским персоналом», «Применение бережливых технологий в медицинских организациях», «Соблюдение преемственности между этапами оказания медицинской помощи».

Распространение цифровых технологий позволяет оптимизировать ресурсы, внедрять инновации, улучшать процесс принятия решений и прогнозировать будущие события. Это создание принципиально новых лечебно-диагностических, управленческих, вспомогательных процессов, полностью основанных на цифровых платформах, а не на оцифрованном документообороте [9, 10]. Исследование выявило проблемы направления в развитии цифровизации здравоохранения на территориях РФ, аффилированных с вузами, по следующим направлениям: «Автоматизация различных отчетов», «Поддержка процесса осуществления приема/посещения», «Использование телеконсультаций врач-врач», «Использование телеконсультаций врач-фельдшер», «Применение дронов для доставки биоматериалов до лаборатории», «Единый реестр зарегистрированных лиц», «Персонифицированный учет медицинской помощи, включая высокотехнологичную медицинскую помощь», «Реестр электронных медицинских документов», «Гибридная реабилитация с применением телемедицинских технологий» и др.

В то же время одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере здравоохранения является обеспечение отрасли квалифицированными МК. Формирование корпуса конкурентоспособных, компетентных и мотивированных кадров является главным условием выполнения системой здравоохранения своей миссии — обеспечения здоровья населения [11]. При этом обеспеченность медицинскими работниками соответствующей квалификации с высшим и, особенно, со средним медицинским образованием изучается недостаточно. В том числе это касается таких тем, как «Передача функций между медицинским персоналом» и «Передача части функций немедицинским специалистам».

Выявлено, что при преподавании дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» недостаточно освещаются вопросы диспансеризации, в том числе «Диспансеризация ветеранов боевых действий», «Стандарты оказания медицинской помощи», темы цифровизации здравоохранения: «Модель пациента, включающая группы, факторы риска, данные о наследственных заболеваниях, клинические данные», «Гибридная реабилитация с применением телемедицинских технологий», «Иммерсивные технологии (виртуальная, дополненная и смешанная реальности)», «Технологии мозг-компьютер-интерфейс». Тема «Проведение скринингового исследования на антитела к гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше» практически не реализуется при подготовке медицинских кадров.

Таким образом, в рабочие образовательные программы дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение», реализуемые в ООБМО и фармацевтического образования темы приоритетных направлений развития здравоохранения в настоящее время введены не в полном объеме.

Ограничение исследования: отсутствие объемов преподавания дисциплины, в рамках которой исследовались темы приоритетных вопросов здравоохранения в подготовке медицинских кадров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для совершенствования подготовки медицинских кадров в условиях реформирования российской системы здравоохранения целесообразно рекомендовать образовательным организациям высшего медицинского образования включить в обязательном порядке в рабочие программы дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» следующие темы: «Трансформация процессов первичного звена здравоохранения», «Цифровизация здравоохранения», «Проведение скринингового исследования на антитела к гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше», «Передача функций между медицинским персоналом», «Применение бережливых технологий в медицинских организациях», «Соблюдение преемственности между этапами оказания медицинской помощи», «Диспансеризация ветеранов боевых действий».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вклад авторов. Н.А. Касимовская — концепция исследования, редактирование; Е.В. Фомина — анализ данных, написание текста; Е.А. Шустикова — поиск литературы, сбор и анализ данных, статистическая обработка; В.А. Решетников — концепция исследования, редактирование. Все авторы одобрили рукопись (версию для публикации), а также согласились нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой ее части.

Этическая экспертиза. Проведение исследования одобрено Локальным этическим комитетом Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) (Протокол № 23-25 от 13.11.2025). Все участники исследования добровольно подписали форму информированного согласия до включения в исследование.

Согласие на публикацию. Авторы получили у всех участников исследования (эксперты из 20 вузов Российской Федерации) согласие на публикацию в научном журнале, включая его электронную версию (дата подписания 10.11.2025). Объем публикуемых данных согласован.

Источники финансирования. Отсутствуют.

Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние 3 года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.

Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).

Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе не применима, новые данные не собирали и не создавали.

Генеративный искусственный интеллект. При создании статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.

Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два рецензента, член редакционной коллегии и научный редактор издания.

ADDITIONAL INFORMATION

Author contributions: N.A. Kasimovskaya: concept of the study, editing; E.V. Fomina: analysis of data, writing the text; E.A. Shustikova: literature search, collection and analysis of data, statistical processing; V.A. Reshetnikov: concept of the study, editing. All authors approved the manuscript (the publication version), and also agreed to be responsible for all aspects of the work, ensuring proper consideration and resolution of issues related to the accuracy and integrity of any part of it.

Ethics approval: The study was approved from the Local Ethics Committee of the I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenovskiy University) (Protocol No. 23-25 of November 13, 2025). All participants of study voluntarily signed an informed consent form before being included in the study.

Consent for publication: The authors obtained consent from all participants of the study (experts from 20 Universities of the Russian Federation) to publish in a scientific journal, including its electronic version (signed on November 10, 2025). The scope of the published data was agreed upon.

Funding sources: No funding.

Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities or interests for the last three years related with for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.

Statement of originality: The authors did not use previously published information (text, illustrations, data) when creating this work.

Data availability statement: The editorial policy regarding data sharing does not applicable to this work, and no new data were collected or created.

Generative AI: Generative AI technologies were not used for article creation.

Provenance and peer-review: This work was submitted to the journal on its own initiative and reviewed according to the usual procedure. Two reviewers, a member of the editorial board and the scientific editor of the publication participated in the review.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Pavlov ChS, Kovalevskaya VI, Varganova DI, et al. Critical thinking in medical education. *Cardiovascular Therapy and Prevention*. 2023;22(25): 3566. doi: 10.15829/1728-8800-2023-3566 EDN: WFAJPR
2. Kagramanyan IN, Tarasenko AI, Kupeeva IA, et al. Historical aspects of the medical education system transformation. *National Health Care (Russia)*. 2021;2(1):32–40. doi: 10.47093/2713-069X.2021.2.1.32-40 EDN: CNAAXM
3. Reshetnikov VA, Kagramanyan IN, Yakushina II, et al. Attitude of Medical Students to the Education Process in the Period of COVID-19 Pandemic.

I.P. Pavlov *Russian Medical Biological Herald*. 2024;32(4):557–568. doi: 10.17816/PAVLOVJ626321 EDN: GLONOR

4. Pavlov ChS, Kovalevskaya VI, Kireeva NV, et al. Educational priorities and programs for the development of research competencies in science-based medical education. *Cardiovascular Therapy and Prevention*. 2022;21(4S):3481. doi: 10.15829/1728-8800-2022-3481 EDN: MSOAKT
5. Reshetnikov VA, Manerova OA, Sozinov AS, Ismayil-zada NT. Formation and development of public health teaching in the system of higher medical education (From social hygiene to public health and health care). *Kazan*

Medical Journal. 2020;101(6):897–907. doi: 10.17816/KMJ2020-897
EDN: QHWRBH

6. Kagramanyan IN, Reshetnikov VA, Manerova OA, et al. Modern Trends in Development of Educational and Scientific Discipline 'Public Health and Healthcare': Its Methodological Role and Integrative Function. *I.P. Pavlov Russian Medical Biological Herald*. 2024;32(2):329–338. doi: 10.17816/PAVLOVJ630115 EDN: HCWPKJ

7. Lebedeva IV, Olenin YA, Gziryana VS. Socio-hygienic factors affecting the health of working-age population of Moscow region (on example of city of Domodedovo). *Science of the Young (Eruditio Juvenium)*. 2021;9(3):387396. doi: 10.23888/HMJ202193387-396 EDN: ZWZBDP

8. Khuzikhanov FV. Some pedagogical approaches in teaching the subject: "Public Health and Healthcare Organization" in medical university. *Public Health and Health Care*. 2013;(4):24–27. EDN: RPDFOF

9. Nurmatova F, Abduganieva Sh. Digital transformation in medicine: trends and prospects. *Universum: Technical Sciences*. 2023;(7):26–29. Available from: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/15779>. Accessed: 01.12.2025. EDN: CWXJBY

10. Tkachenko IN, Chesnyukova LK. Digital technologies in the sphere of health care as a way to ensure the quality of human capital. *Izvestiya of Saratov University. Economics. Management. Law*. 2023;23(2):163–173. doi: 10.18500/1994-2540-2023-23-2-163-173 EDN: IETAHP

11. Mazharov VN, Semenova TV, Reshetnikov VA, et al. Analysis of staffing issues in the health care system and solutions to them (the example of Stavropol Krai): A retrospective analytical descriptive study. *Kuban Scientific Medical Bulletin*. 2025;32(2):69–77. doi: 10.25207/1608-6228-2025-32-2-69-77 EDN: HJYRPZ

ОБ АВТОРАХ

***Касимовская Наталия Алексеевна**, д-р мед. наук, профессор;
адрес: Российская Федерация, 119048, Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2;
ORCID: 0000-0002-1046-4349;
eLibrary SPIN: 7337-2930;
e-mail: kasimovskaya_n_a@staff.sechenov.ru

Фомина Елена Викторовна, канд. мед. наук;
ORCID: 0000-0001-9235-7522;
eLibrary SPIN: 6543-3747;
e-mail: fomina_e_v@staff.sechenov.ru

Шустикова Елена Анатольевна;
ORCID: 0009-0009-9850-1869;
e-mail: shustikova_e_a@staff.sechenov.ru

Решетников Владимир Анатольевич, д-р мед. наук, профессор;
ORCID: 0000-0002-7853-7356;
eLibrary SPIN: 4016-2059;
e-mail: reshetnikov_v_a@staff.sechenov.ru

AUTHORS' INFO

***Nataliya A. Kasimovskaya**, MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor;
address: 8 Trubetskaya st, bldg 2, Moscow, Russian Federation, 119048;
ORCID: 0000-0002-1046-4349;
eLibrary SPIN: 7337-2930;
e-mail: kasimovskaya_n_a@staff.sechenov.ru

Elena V. Fomina, MD, Cand. Sci. (Medicine);
ORCID: 0000-0001-9235-7522;
eLibrary SPIN: 6543-3747;
e-mail: fomina_e_v@staff.sechenov.ru

Elena A. Shustikova;
ORCID: 0009-0009-9850-1869;
e-mail: shustikova_e_a@staff.sechenov.ru

Vladimir A. Reshetnikov, MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor;
ORCID: 0000-0002-7853-7356;
eLibrary SPIN: 4016-2059;
e-mail: reshetnikov_v_a@staff.sechenov.ru

*Автор, ответственный за переписку/Corresponding author